Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

PEG-GRAFEEL

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

Mỗi bơm tiêm đóng sẵn thuốc 0,6 ml chứa:

Thành phần hoạt chất: Pegfilgrastim* 6,0 mg

Thành phần tá dược: D-sorbitol, polysorbate 20, sodium, acetate, nước pha tiêm.

*Sản xuất bởi tế bào của *Escherichia coli* bằng kỹ thuật tái tổ hợp DNA tiếp theo là kết nối với polyethylene glycol (PEG).

Hoạt lực của sản phẩm này không thể so sánh với hoạt lực của sản phẩm protein kết nối hoặc không kết nối với PEG của cùng một nhóm trị liệu.

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch tiêm

Mô tả: Dung dịch trong suốt, không màu, không có các hạt nhìn thấy được.

CHỈ ĐỊNH

Làm giảm thời gian suy giảm bạch cầu trung tính và tỉ lệ bị sốt do giảm bạch cầu trung tính ở các bệnh nhân được chữa trị bằng hóa trị liệu độc tế bào trong điều trị ung thư ác tính (trừ ung thư bạch cầu tủy mạn tính và hội chứng loạn sản tủy).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

Trị liệu bằng pegfilgrastim cần phải được bác sĩ có kinh nghiệm điều trị ung thư hay huyết học chỉ định và theo dõi.

Mỗi liều 6 mg pegfilgrastim (bơm tiêm đơn liều đóng sẵn thuốc) được chỉ định dùng cho một chu kỳ hóa trị liệu tiêm dưới da cách 24 giờ sau khi dùng hóa trị liệu độc tế bào.

Bệnh nhân nhi

Kinh nghiệm sử dụng ở trẻ em còn hạn chế (xem phần *Tác dụng không mong muốn* và *Đặc tính dược động học*).

Tính an toàn và hiệu quả của pegfilgrastim ở trẻ em hiện chưa được thiết lập. Các dữ liệu hiện có mô tả trong các phần *Tác dụng không mong muốn*, *Đặc tính dược lực học* và *Đặc tính dược động học* nhưng chưa có khuyến cáo liều dùng cho trẻ.

Bệnh nhân suy thận

Không cần thay đổi liều cho bệnh nhân bị suy thận kể cả suy thận giai đoạn cuối.

Cách dùng

- Hướng dẫn khi dùng thuốc

Trước khi dùng, nên kiểm tra phần tử lạ trong dung dịch tiêm pegfilgrastim. Chỉ dung dịch trong suốt, không màu mới được tiêm.

Lắc quá mức có thể gây kết tập pegfilgrastim, làm cho mất hoạt tính sinh học của thuốc.

Để bơm tiêm đóng sẵn thuốc đạt nhiệt độ phòng trước khi tiêm.

- Đường dùng: Tiêm dưới da.
- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da vào đùi, bụng hoặc cánh tay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc.

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với filgrastim.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Dữ liệu lâm sàng hạn chế cho thấy pegfilgrastim so với filgrastim có hiệu quả tương đương về thời gian phục hồi triệu chứng giảm bạch cầu trung tính nghiêm trọng ở bệnh nhân mới mắc bệnh bạch cầu tủy bào cấp tính (AML). Tuy nhiên, các tác dụng lâu dài của pegfilgrastim chưa được thiết lập đối với AML; do đó, nên sử dụng thận trọng ở các bệnh nhân này.

Yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của các tế bào myeloid *in vitro* và các tác động tương tự có thể được ghi nhận trên một số tế bào không myeloid *in vitro*.

Sự an toàn và hiệu quả của pegfilgrastim chưa được nghiên cứu ở những bệnh nhân mắc hội chứng loạn sản tủy, bệnh bạch cầu tủy xương mạn tính và ở bệnh nhân mắc AML thứ phát; do đó, không nên sử dụng ở những bệnh nhân như vậy. Cần đặc biệt chú ý nên phân biệt chẩn đoán biến đổi bùng phát của bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính với AML.

Sự an toàn và hiệu quả của việc điều trị bằng pegfilgrastim ở bệnh nhân mới mắc AML ở độ tuổi <55 tuổi với di truyền học tế bào t(15; 17) chưa được thiết lập.

Sự an toàn và hiệu quả của pegfilgrastim chưa được nghiên cứu ở những bệnh nhân dùng hóa trị liệu liều cao.

Tác dụng bất lợi trên phổi

Các tác dụng bất lợi trên phổi hiếm gặp (≥1/10.000 đến <1/1.000) đặc biệt là viêm phổi kẽ, đã được báo cáo sau khi dùng G-CSF. Bệnh nhân có tiền sử thâm nhiễm phổi hoặc viêm phổi gần đây có thể có nguy cơ cao hơn.

Sự xuất hiện của các dấu hiệu trên phổi như ho, sốt và khó thở liên quan đến các dấu hiệu X quang của thâm nhiễm phổi, và suy giảm chức năng phổi cùng với số lượng bạch cầu trung tính tăng có thể là dấu hiệu ban đầu của hội chứng suy hô hấp ở người lớn (ARDS). Trong những trường hợp như vậy, nên ngưng dùng pegfilgrastim theo quyết định của bác sĩ và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.

Viêm cầu thận

Viêm cầu thận đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng filgrastim và pegfilgrastim. Nói chung, các sự kiện viêm cầu thận được giải quyết sau khi giảm liều hoặc ngưng filgrastim và pegfilgrastim. Khuyến cáo nên theo dõi kết quả xét nghiệm nước tiểu.

Hội chứng rò rỉ mao mạch

Hội chứng rò rỉ mao mạch đã được báo cáo sau khi sử dụng yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt và được đặc trưng bởi hạ huyết áp, giảm albumin huyết, phù nề và cô đặc máu. Bệnh nhân phát triển các triệu chứng của hội chứng rò mao mạch nên được theo dõi chặt chẽ và được điều trị triệu chứng theo tiêu chuẩn, có thể bao gồm nhu cầu chăm sóc đặc biệt (xem phần *Tác dụng không mong muốn*).

Lách to và vỡ lách

Các trường hợp không phổ biến nhưng thường không có triệu chứng của lách to và các trường hợp vỡ lách không phổ biến, bao gồm một số trường hợp tử vong, đã được báo cáo sau khi dùng pegfilgrastim (xem phần *Tác dụng không mong muốn*). Do đó, kích thước lách phải được theo dõi cẩn thận (ví dụ: khám lâm sàng, siêu âm). Cần xem xét chẩn đoán vỡ lách ở bệnh nhân báo cáo đau bụng trên bên trái hoặc đau đầu vai.

Giảm tiểu cầu và thiếu máu

Điều trị bằng pegfilgrastim đơn thuần không loại trừ giảm tiểu cầu và thiếu máu vì hóa trị liệu ức chế tủy đủ liều được duy trì theo lịch trình quy định. Cần theo dõi thường xuyên số lượng tiểu cầu và hematocrit. Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các thuốc hóa trị liệu đơn hoặc kết hợp được biết là gây giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

Cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các thuốc hóa trị liệu đơn hoặc kết hợp được biết là gây giảm tiểu cầu nặng.

Thiếu máu hồng cầu hình liềm

Các cơn tan máu do hồng cầu hình liềm có liên quan đến việc sử dụng pegfilgrastim ở những bệnh nhân mắc hồng cầu hình liềm thể nhẹ hoặc bệnh hồng cầu hình liềm (xem phần *Tác dụng không mong muốn*). Do đó, các bác sĩ nên thận trọng khi kê đơn thuốc pegfilgrastim ở bệnh nhân mắc hồng cầu hình liềm thể nhẹ hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, nên theo dõi các thông số lâm sàng và kết quả xét nghiệm phù hợp và chú ý đến mối liên quan có thể của thuốc này với sự tăng kích thước lách và cơn tắc mạch.

Tăng bạch cầu

Số lượng tế bào bạch cầu (WBC) từ 100 x 10^9/l trở lên đã được quan sát thấy ở dưới 1% bệnh nhân dùng pegfilgrastim. Không có tác dụng phụ liên quan trực tiếp đến mức độ tăng bạch cầu này đã được báo cáo. Sự tăng cao như vậy ở các tế bào bạch cầu là thoáng qua, thường thấy sau 24 đến 48 giờ sau khi dùng và phù hợp với các tác dụng dược lực học của pegfilgrastim. Phù hợp với các tác dụng lâm sàng và khả năng tăng bạch cầu, xét nghiệm đếm số lượng WBC nên được thực hiện đều đặn trong suốt quá trình trị liệu. Nếu số lượng bạch cầu vượt quá 50 x 10^9/l sau điểm đáy dự kiến, nên ngừng thuốc này ngay lập tức.

Quá mẫn

Quá mẫn, bao gồm phản ứng phản vệ, xảy ra trong điều trị ban đầu hoặc sau đó đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng pegfilgrastim. Ngừng vĩnh viễn pegfilgrastim ở những bệnh nhân quá mẫn cảm lâm sàng. Không dùng pegfilgrastim cho bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với pegfilgrastim hoặc filgrastim. Nếu một phản ứng dị ứng nghiêm trọng xảy ra, nên điều trị thích hợp, theo dõi chặt chẽ bệnh nhân trong vài ngày.

Tính sinh miễn dịch

Như với tất cả các protein điều trị, thuốc có khả năng gây miễn dịch. Tỷ lệ tạo kháng thể chống lại pegfilgrastim thường thấp. Gắn kết kháng thể xảy ra như dự kiến với tất cả các thuốc sinh phẩm; tuy nhiên, hiện tại chúng không liên quan đến hoạt động trung hòa.

Viêm động mạch chủ

Viêm động mạch chủ đã được ghi nhận sau khi dùng G-CSF ở những người khỏe mạnh và ở bệnh nhân ung thư. Các triệu chứng gặp phải bao gồm sốt, đau bụng, khó chịu, đau lưng và tăng dấu hiệu viêm (ví dụ: protein phản ứng c và số lượng bạch cầu). Trong hầu hết các trường hợp, viêm động mạch chủ được chẩn đoán bằng CT scan và thường được giải quyết sau khi ngưng GCSF. Xem thêm phần *Tác dụng không mong muốn.*

Sự an toàn và hiệu quả của pegfilgrastim đối với việc huy động các tế bào tiền thân máu ở bệnh nhân hoặc người hiến tặng khỏe mạnh chưa được đánh giá đầy đủ.

Vỏ kim của bơm tiêm có chứa cao su khô tự nhiên (một dẫn xuất của latex), có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Tăng hoạt động tạo máu của tủy xương để đáp ứng với liệu pháp yếu tố tăng trưởng có liên quan đến kết quả hình ảnh xương dương tính tạm thời. Điều này nên được xem xét khi giải thích kết quả hình ảnh xương.

Pegfilgrastim chứa D-sorbitol. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp là không dung nạp fructose không nên dùng thuốc này.

Pegfilgrastim chứa ít hơn 1 mmol (23 mg) natri mỗi liều 6 mg, tức là về cơ bản 'không chứa natri'.

Để cải thiện khả năng truy nguyên của các yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt (G-CSFs), tên thương mại của sản phẩm sử dụng phải được ghi rõ trong hồ sơ bệnh nhân.

Tiềm năng tác dụng kích thích tăng trưởng khối u trên các tế bào ác tính

Các thụ thể của yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt (G-CSF) thông qua hoạt động của pegfilgrastim và filgrastim đã được tìm thấy trên các dòng của tế bào khối u. Không thể loại trừ khả năng pegfilgrastim là yếu tố tăng trưởng cho bất kỳ loại khối u nào, bao gồm cả khối u ác tính và loạn sản tủy, những bệnh mà pegfilgrastim không được phê duyệt.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Không có nghiên cứu có kiểm soát tốt và đầy đủ ở phụ nữ có thai. Pegfilgrastim là chất độc trên phôi thai và tăng tỷ lệ sảy thai ở thỏ mang thai nhận liều tích lũy khoảng 4 lần liều khuyến cáo ở con người (dựa trên diện tích bề mặt cơ thể). Dấu hiệu nhiễm độc trên người mẹ xảy ra ở những liều này. Chỉ nên sử dụng pegfilgrastim trong khi mang thai nếu lợi ích có thể mang lại cho người mẹ cân bằng với nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi.

Trong các nghiên cứu sinh sản trên động vật, khi thỏ mang thai dùng pegfilgrastim với liều tích lũy gấp khoảng 4 lần liều khuyến cáo ở người (dựa trên diện tích bề mặt cơ thể), làm tăng tỷ lệ chết thai và sảy thai tự nhiên. Dấu hiệu nhiễm độc ở người mẹ (giảm mức tăng trọng lượng cơ thể/lượng thực phẩm tiêu thụ) và giảm trọng lượng thai nhi xảy ra ở liều tương đương với liều khuyến cáo của con người (dựa trên diện tích bề mặt cơ thể). Không có bất thường về cấu trúc được quan sát thấy ở thỏ ở bất kỳ liều nào được thử nghiệm. Không có bằng chứng về độc tính sinh sản/phát triển xảy ra ở con của chuột cái mang thai đã nhận được liều pegfilgrastim tích lũy khoảng 10 lần so với liều khuyến cáo ở người.

Phụ nữ cho con bú

Người ta không biết liệu pegfilgrastim có được tiết ra trong sữa mẹ hay không. Các sản phẩm G-CSF tái tổ hợp khác được tiết ra kém trong sữa mẹ và G-CSF không được hấp thụ bằng đường uống ở trẻ sơ sinh. Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Hiện chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc được thực hiện.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Tương tác

Do nhạy cảm tiềm ẩn của sự phân chia nhanh của tế bào tủy với hóa trị liệu độc tế bào, pegfilgrastim nên dùng ít nhất 24 giờ sau khi dùng hóa tri liệu độc tế bào. Trong nghiên cứu lâm sàng, pegfilgrastim được dùng an toàn 14 ngày trước hóa trị liệu. Dùng đồng thời pegfilgastim với bất kỳ tác nhân hóa tri liệu chưa được đánh giá ở bệnh nhân. Ở động vật, dùng đồng thời pegfilgrastim và 5-fluorouracil (5-FU) hay chất chống chuyển hóa khác cho thấy có khả năng gây suy tủy.

Có thể tương tác với các yếu tố tạo huyết khác và sự phân bào chưa có nghiên cứu đặc hiệu trên nghiên cứu lâm sàng.

Tiềm năng tương tác với lithium, cũng thúc đẩy phóng thích bạch cầu trung tính, chưa được nghiên cứu đặc hiệu. Không có bằng chứng thấy tương tác này là có hại.

Hiệu quả và độ an toàn của pegfilgrastim chưa được đánh giá ở bệnh nhân dùng hóa trị liệu liên quan tới suy tủy kéo dài, ví dụ nitrosourease.

Tương tác đặc biệt hay nghiên cứu chuyển hóa chưa được thực hiện, tuy nhiên nghiên cứu lâm sàng chưa thấy tương tác của pegfilgrastim với bất kỳ thuốc khác.

Tương kỵ

Thuốc này không được trộn lẫn với thuốc khác, đặc biệt với dung dịch natri clorid.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tóm tắt hồ sơ an toàn

Các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất là đau xương (rất phổ biến ≥1/10) và đau cơ xương khớp (phổ biến). Đau xương nói chung xảy ra ở mức độ từ nhẹ đến vừa phải, đau thoáng qua và có thể được kiểm soát ở hầu hết các bệnh nhân với thuốc giảm đau tiêu chuẩn.

Phản ứng quá mẫn, bao gồm sốc phản vệ, phát ban da, nổi mề đay, phù mạch, khó thở, hạ huyết áp, phản ứng tại chỗ tiêm, ban đỏ và đỏ bừng, xảy ra khi điều trị ban đầu hoặc sau đó đã được báo cáo với pegfilgrastim không phổ biến (≥1/1.000 tới <1/100) (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Hội chứng rò rỉ mao mạch, có thể đe dọa tính mạng nếu việc điều trị bị trì hoãn, đã được báo cáo là không phổ biến (≥ 1/1.000 đến <1/100) ở bệnh nhân ung thư trải qua hóa trị liệu sau khi sử dụng các yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt; **xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc* và phần *"Mô tả các phản ứng bất lợi chọn lọc"* bên dưới.**

Các trường hợp không phổ biến nhưng thường không có triệu chứng của lách to và các trường hợp vỡ lách rất hiếm gặp, bao gồm một số trường hợp tử vong, đã được báo cáo sau khi sử dụng pegfilgrastim (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Tác dụng bất lợi trên phổi không phổ biến bao gồm viêm phổi kẽ, phù phổi, thâm nhiễm phổi và xơ phổi đã được báo cáo. Các trường hợp đã dẫn đến suy hô hấp hoặc Hội chứng suy hô hấp ở người trưởng thành (ARDS) không phổ biến, và có thể gây tử vong (xem phần *Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi dùng thuốc*).

Các trường hợp riêng biệt của cơn tan máu do hồng cầu hình liềm đã được báo cáo ở những bệnh nhân mắc hồng cầu hình liềm thể nhẹ hoặc bệnh hồng cầu hình liềm (không phổ biến ở bệnh nhân bị bệnh hồng cầu hình liềm) (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Bảng tóm tắt tổng hợp các phản ứng bất lợi

Dữ liệu trong bảng dưới đây mô tả các phản ứng bất lợi được báo cáo từ các thử nghiệm lâm sàng và báo cáo tự phát. Trong mỗi nhóm tần suất, các tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm dần mức độ nghiêm trọng.

Phân loại cơ quan theo hệ thống MedDRA	**Phản ứng bất lợi**				
	Rất phổ biến (≥ 1/10)	**Phổ biến (≥ 1/100 tới < 1/10)**	**Không phổ biến (≥ 1/1.000 tới < 1/100)**	**Hiếm gặp (≥ 1/10.000 tới < 1/1.000)**	**Rất hiếm gặp (< 1/10.000)**
Rối loạn hệ thống máu và bạch huyết		Giảm tiểu cầu[1] Tăng bạch cầu[1]	Cơn tan máu do hồng cầu hình liềm[2]; Lách to[2]; Vỡ lách[2]		
Rối loạn hệ thống miễn dịch			Phản ứng quá mẫn; Sốc phản vệ		
Rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa			Tăng axit uric		
Rối loạn hệ thần kinh	Đau đầu[1]				
Rối loạn mạch máu			Hội chứng rò rỉ mao mạch[1]		
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất			Hội chứng suy hô hấp cấp tính[2]; Phản ứng bất lợi trên phổi (viêm		

			phổi kẽ, phù phổi, thâm nhiễm phổi và xơ phổi)		
Rối loạn tiêu hóa	Buồn nôn[1]				
Rối loạn da và mô dưới da			Hội chứng Sweet (viêm da sốt cấp tính)[1,2]; Viêm mạch máu da[1,2]		
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Đau xương	Đau cơ xương khớp (đau cơ, đau khớp, đau tứ chi, đau lưng, đau cơ xương, đau cổ)			
Rối loạn chung và điều kiện tại chỗ tiêm		Đau chỗ tiêm[1] Đau ngực không do tim	Phản ứng chỗ tiêm[2]		
Điều tra nghiên cứu			Tăng lactate dehydrogenase và kiềm phosphatase[1]; Tăng LFT cho ALT hoặc AST tạm thời[1]		
Rối loạn thận và tiết niệu			Viêm cầu thận[2]		

[1] Xem phần "Mô tả các phản ứng bất lợi chọn lọc" bên dưới.

[2] Phản ứng bất lợi này được xác định thông qua giám sát sau khi sử dụng trên thị trường nhưng không được quan sát trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có kiểm soát ở người lớn. Phân loại tần suất được ước tính từ một tính toán thống kê dựa trên 1576 bệnh nhân dùng pegfilgrastim trong chín thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

Mô tả các phản ứng bất lợi chọn lọc

Các ca không phổ biến của hội chứng Sweet đã được báo cáo, mặc dù trong một số trường hợp các khối u huyết học ác tính tiềm ẩn có thể đóng một vai trò trong đó.

Các trường hợp không phổ biến của viêm mạch máu da đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng pegfilgrastim. Cơ chế của viêm mạch máu ở bệnh nhân dùng pegfilgrastim vẫn chưa được biết đến.

Phản ứng tại chỗ tiêm, bao gồm ban đỏ tại chỗ tiêm (không phổ biến (≥ 1/1000 đến <1/100) cũng như đau tại chỗ tiêm (các biến cố thường gặp ≥1/100 đến <1/10) đã xảy ra khi điều trị ban đầu hoặc sau đó bằng pegfilgrastim.

Các trường hợp phổ biến (≥ 1/100 đến <1/10) của chứng tăng bạch cầu ([WBC] > 100 x 10^9/l) đã được báo cáo (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Ngược lại, tăng axit uric và phosphatase kiềm mức độ nhẹ đến trung bình, không liên quan đến các hiệu quả lâm sàng, là không phổ biến; tăng lactate dehydrogenase mức độ nhẹ đến trung

bình có thể hồi phục, không có liên quan hiệu quả lâm sàng, xảy ra không phổ biến ở những bệnh nhân sử dụng pegfilgrastim sau hóa trị liệu độc tế bào.
Buồn nôn và đau đầu rất thường gặp ở những bệnh nhân được hóa trị.
Sự gia tăng không phổ biến trong các xét nghiệm chức năng gan (LFT) về ALT (alanine aminotransferase) hoặc AST (aspartate aminotransferase), đã được quan sát thấy ở bệnh nhân dùng pegfilgrastim sau hóa trị liệu độc tế bào. Sự gia tăng này là thoáng qua và có thể trở lại giá trị bình thường.
Các trường hợp giảm tiểu cầu là phổ biến.
Các trường hợp hội chứng rò rỉ mao mạch đã được báo cáo sau khi yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt được sử dụng trên thị trường. Những trường hợp này thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc các bệnh ác tính tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, dùng nhiều loại thuốc hóa trị hoặc trải qua quá trình phân tách thành phần máu (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Trẻ em

Các tác dụng bất lợi nghiêm trọng ở trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi (92%) đã được quan sát với tần suất cao hơn so với trẻ lớn hơn ở độ tuổi 6-11 và 12-21 tuổi (80% và 67%) và người lớn. Phản ứng bất lợi phổ biến nhất là đau xương (xem phần *Đặc tính dược động học*).

Người già

Trong số 932 bệnh nhân mắc bệnh ung thư đã sử dụng pegfilgrastim trong các nghiên cứu lâm sàng, 139 (15%) ở độ tuổi từ 65 trở lên và 18 (2%) ở độ tuổi 75 trở lên. Không có sự khác biệt tổng thể về an toàn hoặc hiệu quả đã được quan sát giữa bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên và bệnh nhân trẻ tuổi.

Kinh nghiệm sau khi ra thị trường

Vỡ lách và lách to, hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), phản ứng dị ứng/quá mẫn, bao gồm sốc phản vệ, phát ban da, nổi mày đay, ban đỏ, và đỏ bừng, cơn tan máu do hồng cầu hình liềm, viêm cầu thận, tăng bạch cầu, hội chứng rò rỉ mao mạch, phản ứng tại chỗ tiêm, hội chứng Sweet (viêm da sốt cấp tính), viêm mạch máu da đã được xác định trong quá trình sử dụng pegfilgrastim sau khi được phê duyệt.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có kinh nghiệm quá liều pegfilgrastim ở người.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý trị liệu: yếu tố kích thích miễn dịch, điều hòa dòng; Mã ATC: L03AA13.
Yếu tố kích thích dòng bạch cầu hạt người (G-CSF) là một glycoprotein, có tác dụng điều hòa sản xuất và phóng thích bạch cầu trung tính từ tủy xương. Pegfilgrastim là hợp chất cộng hóa trị của yếu tố G-CSF tái tổ hợp của người (r-metHuG-CSF) với đơn phân tử PEG có khối lượng là 20kDa. Pegfilfrastim là dạng giải phóng chậm của filgrastim do giảm độ thanh thải qua thận. Pegfilgrastim và filgrastim được xem là có cơ chế tác động giống nhau, làm gia tăng số lượng bạch cầu trung tính đếm được ở máu ngoại vi trong 24 giờ và làm tăng chút ít đơn bào hay lympho bào. Tương tự như filgrastim, bạch cầu trung tính đáp ứng với tác động của pegfilgrastim có chức năng hoạt động bình thường hay tăng được chứng minh bởi thử nghiệm chức năng hóa ứng động và thực bào.
Cũng như các yếu tố tăng trưởng tế bào tạo máu khác, G-CSF chứng tỏ có tác dụng kích thích tế bào nội bì người *in vitro*. G-CSF có thể thúc đẩy tăng trưởng của tế bào tủy, bao gồm tế bào ác tính *in vitro* và cho kết quả tương tự đối với một số tế bào khác không phải tế bào tủy.

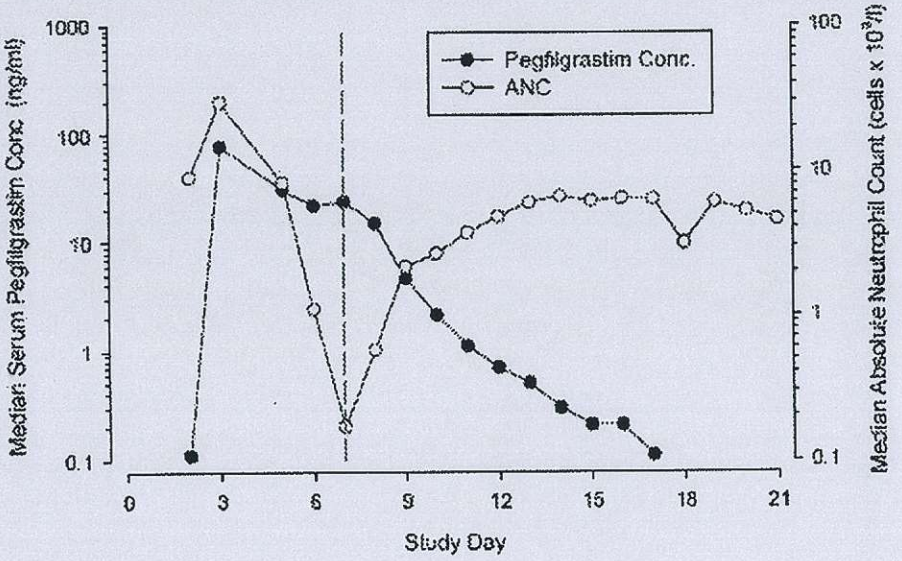
Cơ chế tác động

Pegfilgrastim là một yếu tố kích thích dòng tế bào tác động trên tế bào tạo máu bằng cách gắn kết vào các thụ thể của tế bào đặc hiệu do đó kích thích sự phát triển, biệt hóa, chuyển giao và hoạt hóa chức năng tế bào đích.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi tiêm dưới da đơn liều pegfilgrastim, nồng độ đỉnh huyết thanh đo được ở 16 giờ đến 120 giờ và duy trì trong thời gian giảm bạch cầu trung tính sau khi hóa trị liệu suy tủy. Thải trừ pegfilgrastim không tuyến tính so với liều dùng; độ thanh thải huyết thanh giảm khi liều dùng tăng. Pegfilgrastim chủ yếu được thải trừ qua trung gian bạch cầu trung tính và trở nên bão hòa ở liều cao. Phù hợp với cơ chế tự điều chỉnh sự thải trừ, nồng độ pegfilgrastim trong huyết thanh sẽ giảm nhanh khi số lượng bạch cầu trung tính được phục hồi (xem hình 1).

Hình 1: Nồng độ huyết thanh trung bình của pegfilgrastim và đếm bạch cầu trung tính tuyệt đối trong hóa trị liệu ở bệnh nhân sau khi tiêm đơn liều 6,0 mg.



Study Day: Ngày nghiên cứu.

Median Serum Pegfilgrastim Conc. (ng/ml): Nồng độ pegfilgrastim huyết thanh trung bình (ng/ml).

Median Absolute Neutrophil count (cell x 10^9/l): Bạch cầu trung tính tuyệt đối trung bình (tế bào x 10^9/l).

Pegfilgrastim Conc.: Nồng độ pegfilgrastim.

ANC: Bạch cầu trung tính tuyệt đối.

Cũng do cơ chế thải trừ qua trung gian bạch cầu trung tính, dược động học của pegfilgrastim sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng gan suy hoặc thận suy. Trong thử nghiệm mở, dùng một liều duy nhất trên 31 bệnh nhân, với nhiều cấp độ suy thận khác nhau, kể cả tình trạng suy thận giai đoạn cuối cũng không làm ảnh hưởng đến dược động học của pegfilgrastim.

Các dữ liệu còn hạn chế chứng tỏ dược động học của pegfilgrastim ở người già (> 65 tuổi) cũng tương tự như dược động học ở người lớn trưởng thành.

Bệnh nhân nhi

Dược động học của pegfilgrastim được khảo sát trên 37 trẻ em bị ung bướu, với liều 100µg/kg theo trọng lượng cơ thể, sau khi hoàn tất hóa trị liệu Vincristin-Adriamycin-Cyclophosphamid/ ifosphamid-etoposid (V Adria C/IE). Trẻ nhỏ tuổi nhất (0-5 tuổi) phơi nhiễm trung bình với pegfilgrastim (có diện tích dưới đường cong AUC ± độ lệch chuẩn là 47,9±22,5µg.giờ/mL) cao hơn là đối với trẻ lớn tuổi hơn 6-11 tuổi và 12-21 tuổi (lần lượt là 22,0±13,1µg.giờ/mL và 29,3±23,2µg.giờ/mL). Ngoại lệ, nhóm trẻ tuổi nhất (0-5 tuổi) trị số trung bình của diện tích dưới đường cong (AUC) của bệnh nhân nhi cũng tương tự như của bệnh nhân người lớn bị ung thư vú với nguy cơ cao ở giai đoạn II- IV và được điều trị với liều pegfilgrastim là 100µg/kg

theo trọng lượng cơ thể sau khi hoàn tất sử dụng doxorubicin/docetaxel (xem *Tác dụng không mong muốn*).

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

0,6 ml dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn thuốc (thủy tinh loại 1) với nắp cao su và kim tiêm không rỉ đóng trong đồ bảo vệ tự động. Chỉ dùng 1 lần.

Vỏ kim của bơm tiêm có chứa cao su thiên nhiên khô (dẫn xuất của latex) (xem phần *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc 0,6 ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản trong tủ lạnh 2-8^{0}C. Không đông lạnh.

Giữ thuốc trong hộp để tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG, KHI LOẠI BỎ

Trước khi dùng, nên kiểm tra phần tử lạ trong dung dịch tiêm pegfilgrastim. Chỉ dung dịch trong suốt, không màu mới được tiêm.

Lắc quá mức có thể gây kết tập pegfilgrastim, làm cho mất hoạt tính sinh học của nó.

Để bơm tiêm đóng sẵn thuốc đạt nhiệt độ phòng trước khi tiêm.

Bất kỳ sản phẩm nào không sử dụng hay hay nguyên liệu thừa nên bỏ đi theo yêu cầu của địa phương.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

DR. REDDY'S LABORATORIES LTD.

Biologics, Survey No. 47, Bachupally (V), Bachupally (M),

Medchal Malkajgiri (Dist.), Telangana (State), India.

DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Preet Darshi Patnaik